

Fonctionnement des Unités de Surveillance Continue (USC)

Champs 1-2 — Typologie des patients & structure des USC



Résumé : recommandations conjointes des Conseils Nationaux Professionnels de Médecine Intensive Réanimation, Anesthésie-Réanimation et Médecine d'Urgence (2018) sur l'organisation des Unités de Surveillance Continue (USC) — « soins intermédiaires » entre unité standard et réanimation. 26 recommandations (accord fort) sur 5 champs : typologie des patients, structure des USC, organisation paramédicale, organisation médicale, USC dans le contexte des GHT.

Fort

Convention de ce document : chaque recommandation est suivie de la seule mention « **Accord Fort** » — pas de grille GRADE numérique, pas de distinction avis d'experts/recommandation graduée. 26 recommandations, toutes à accord fort, sur 5 champs. Aucune absence de recommandation dans ce document.

Champ 1 — Typologie des patients

Réf.	Recommandation	Grade
R1.1	Sélectionner les patients pris en charge en USC dans un objectif de sécurité médicale, et non d'éligibilité à un tarif.	Fort
R1.2	Organiser les USC pour prendre en charge des patients à risque de défaillance vitale nécessitant une surveillance rapprochée, avec capacité de faire face à la défaillance et de préparer un transfert rapide en réanimation.	Fort
R1.3	Adapter les moyens et compétences des USC aux filières de l'établissement (post-opératoire, urgences, post-réanimation, activités à risque) ; dans les centres sans réanimation, tenir compte des délais de transfert.	Fort
R1.4	Les USC n'ont pas pour mission d'assurer la suppléance d'organe des patients en défaillance, en dehors de la préparation d'un transfert en réanimation.	Fort
R1.5	Les USC ne doivent pas recevoir de patients pour engager un processus de fin de vie.	Fort

Champ 2 — Structure des USC

Réf.	Recommandation	Grade
R2.1	L'existence de lits d'USC dans une structure hospitalière devrait être soumise à autorisation.	Fort
R2.2	Si l'établissement comporte une unité de réanimation, l'USC doit être placée sous la même autorité médicale et paramédicale que cette unité.	Fort
R2.3	Une USC doit avoir un projet médical et paramédical qui lui est spécifique.	Fort
R2.4	Sans unité de réanimation sur site, la mission et l'organisation de l'USC doivent être précisées et intégrées au projet médical des soins critiques du GHT.	Fort
R2.5	Avec unité de réanimation, les lits d'USC peuvent être intégrés à cette unité ou constituer une unité distincte à proximité.	Fort
R2.6	Regrouper le plus possible les lits de soins critiques au sein d'une structure hospitalière.	Fort
R2.7	Ne pas descendre, hors particularités géographiques, en dessous de 6 lits pour une USC.	Fort

Fonctionnement des Unités de Surveillance Continue (USC)

Champs 3-4 — Organisation paramédicale & médicale



Champ 3 — Organisation et management paramédical

Réf.	Recommandation	Grade
R3.1	L'équipe paramédicale d'une USC doit faire l'objet d'une organisation et d'un projet de soins spécifiques.	Fort
R3.2	Les paramédicaux exerçant en USC doivent recevoir une formation d'adaptation à l'emploi spécifique aux patients à risque de défaillance vitale.	Fort
R3.3	Cette formation doit aborder les aspects techniques, de prévention/qualité, et humains/psychologiques.	Fort
R3.4	L'effectif paramédical (IDE + AS) physiquement présent et affecté aux soins doit être $\geq 0,4$ par lit ouvert.	Fort
R3.5	Avec réanimation sur site, mutualiser le planning IDE entre USC et réanimation (rotation des personnels) ; sans réanimation, mutualiser avec les autres soins critiques (urgences, soins intensifs).	Fort

Champ 4 — Organisation et management médical

Réf.	Recommandation	Grade
R4.1	Les médecins exerçant en USC doivent avoir une formation initiale ou attestée à l'activité de soins critiques (anesthésie-réanimation, médecine intensive-réanimation ou médecine d'urgence).	Fort
R4.2	L'équipe médicale d'une USC rattachée à un service de réanimation doit être sous la même responsabilité que ce service.	Fort
R4.3	Sans unité de réanimation, l'équipe médicale de l'USC doit être sous la responsabilité d'un médecin exerçant à temps majoritaire dans l'USC.	Fort
R4.4	Assurer la présence d'un médecin sur site 24h/24, 7j/7 (répondant aux critères de R4.1) ; mutualiser la permanence de nuit/week-end/jours fériés avec le service de rattachement (ou les autres soins critiques si pas de réanimation).	Fort
R4.5	Sans service de réanimation, assurer la formation continue et l'évaluation des pratiques en coopération avec le réseau de soins critiques du GHT.	Fort

Fonctionnement des Unités de Surveillance Continue (USC)

Champ 5 — GHT, critères d'admission & sources



Champ 5 — USC dans le contexte des GHT

Réf.	Recommandation	Grade
R5.1	Les GHT doivent organiser la filière de soins critiques intégrant les USC selon le volume et la gravité des filières de patients « à risque ».	Fort
R5.2	Sans unité de réanimation in situ, l'USC doit établir une convention avec l'unité de réanimation du GHT.	Fort
R5.3	Une USC doit avoir un projet d'unité précisant ses missions au sein du GHT, ses objectifs, et les catégories de patients qu'elle prend en charge.	Fort
R5.4	Pour les USC isolées, favoriser le partage de temps médical avec des réanimations partenaires (« pôle de soins critiques inter-établissements »), pour éviter l'isolement et les problèmes d'attractivité.	Fort

Tableau — Critères d'admission en USC (American College of Critical Care, cité par le source)

Appareil	Indications d'admission en USC
Cardiovasculaire	Suspicion d'IDM ou IDM hémodynamiquement stable ; troubles du rythme bien tolérés ; entraînement électrosystolique stable ; décompensation cardiaque modérée (NYHA 1-2) ; urgence hypertensive sans défaillance d'organe.
Respiratoire	Sevrage ventilatoire avec soins chroniques ; défaillance respiratoire stable nécessitant surveillance rapprochée et/ou CPAP ; besoin de soins/kinésithérapie respiratoire intense.
Neurologique	AVC stable nécessitant évaluations/nursing rapprochés ; traumatisme crânien aigu Glasgow > 9 sous surveillance ; surveillance post-traitement d'anévrisme cérébral ; fuite de LCR ; trauma médullaire cervical stable ; hémorragie méningée non sévère en attente de sécurisation.
Intoxications	Surveillance cardiaque/pulmonaire/neurologique après intoxication médicamenteuse chez un patient stable.
Digestif	Hémorragie digestive modérée répondant au remplissage ; rupture de VO de faible intensité chez un patient stable ; insuffisance hépatocellulaire aiguë sans gravité vitale.
Endocrinien	Acidocétose ou décompensation hyperosmolaire sans coma ; thyrotoxicose/coma myxœdémateux.
Chirurgical	Transfusion/remplissage postopératoire chez un patient stable ; 24 premières heures postopératoires à soins infirmiers rapprochés (carotide, chirurgie vasculaire périphérique, neurochirurgie, greffe rénale...).
Divers	Sepsis stable sans choc ni défaillance d'organe ; monitoring du remplissage vasculaire ; pré-éclampsie/éclampsie ; soins infirmiers lourds ou pansements complexes.

Sources et avertissement

Document source : Conseils Nationaux Professionnels de Médecine Intensive Réanimation, d'Anesthésie-Réanimation et de Médecine d'Urgence, « Recommandations pour le fonctionnement des Unités de Surveillance Continue (USC) dans les Établissements de Santé », 2018.

URL source : <https://sfar.org/wp-content/uploads/2018/05/EXTE-USC-CNP.pdf>

Couverture : intégralité des 26 recommandations (5 champs), toutes à accord fort — aucune absence de recommandation dans ce document. Le tableau des critères d'admission ACCC (référence externe citée par le source) est reproduit intégralement. L'Annexe 1 (actes consommateurs de temps IDE) et les Tableaux 1-3 (valorisation tarifaire, organisation, charge en soins) ne sont pas retranscrits — administratifs/méthodologiques, non actionnables au chevet. Bibliographie et composition nominative du groupe de travail non reproduites.

Avvertissement : cette fiche est une synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend intégralement les 26 recommandations du texte source, mais condense l'argumentaire de chaque item. Elle ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par les Conseils Nationaux Professionnels concernés.